



Rubrieken: [Nieuws & Mededelingen](#) | [Beleid en kwaliteit](#) | [HR](#) | [Bibliotheek](#)

Zoeken 

Kwaliteitsdocument | 215 | Rapporteren

Versie: 2025

Vastgesteld door: Raad van Bestuur

Doel

Interne overdracht

Rapportages ondersteunen de samenwerking tussen verschillende disciplines (zoals woonbegeleiders, werkbegeleiders, locatietoördinatoren en gedragswetenschappers). Hierdoor wordt de zorg voor de cliënt eenduidig en zorgvuldig overgedragen/vormgegeven.

Tijdig signaleren van gedragsveranderingen

Door rapportages worden patronen in het gedrag en welzijn van de cliënt sneller zichtbaar. Begeleiders en de gedragswetenschapper kunnen hierdoor veranderingen tijdig signaleren en passende ondersteuning bieden.

Monitoren van effecten van behandelingen of aanpassing van afspraken

Rapportages geven inzicht in de doelmatigheid en de effecten van ingezette behandelingen en gemaakte afspraken, zodat deze waar nodig kunnen worden aangepast aan de behoeften van de cliënt.

Input geven voor de ondersteuning van de cliënt (het ondersteuningsplan)

Rapportages helpen om beter aan te sluiten bij wat de cliënt nodig heeft en waar kansen liggen voor ontwikkeling. Ze vormen daarmee een fundament voor persoonlijke doelen in het zorgplan.

Kwaliteits- en rechtmatigheidscontrole

Rapportages maken inzichtelijk welke zorg aan de cliënt is geleverd. Op basis hiervan kan zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve controle plaatsvinden. Een kwalitatieve controle richt zich op de inhoud, kwaliteit en veiligheid van de zorg, en wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Een kwantitatieve controle richt zich op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde zorg, en wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld zorgfinanciers of de controlerend accountant.

De SOAP- methode

Binnen Albero Zorggroep hanteren we voor het schrijven van rapportages de SOAP- methode.

Deze methode helpt om informatie gestructureerd vast te leggen door vier stappen te volgen:

1. subjectieve waarneming
2. objectieve waarneming
3. analyse
4. plan.

Hieronder worden de termen nader toegelicht in het stappenplan:

Stap 1: Omschrijf de **subjectieve waarneming**. Dit is informatie afkomstig van de cliënt zelf en is gebaseerd op persoonlijke ervaringen, gevoelens of meningen: Wat zegt de cliënt (of diens familie) over de eigen beleving?

Voorbeeld:

- *Cliënt geeft aan zich niet goed te voelen en dat ze in paniek is.*
- *De cliënt geeft aan dat ze verdrietig is omdat zij alleen is.*
- *De familie meldt dat cliënt vaak boos is thuis.*
- *De cliënt zegt dat zij slecht geslapen heeft.*

Stap 2: Omschrijf jouw **objectieve waarneming**. Dit is de informatie die jij zelf geobserveerd hebt. Dit kan gaan om gedrag van de cliënt of een observatie van de ruimte. Ben hier zo concreet mogelijk in, Hoe vaak komt het gedrag voor? Wat zie je, wat hoor je? Vermijd interpretatie of aannames. Noteer ook hoe vaak of lang iets voorkomt.

Voorbeelden:

- *Cliënt loopt tien minuten heen en weer door de kamer terwijl die praat.*
- *In de badkamer ligt een plas water van ongeveer 1 m2 op de vloer.*
- *De cliënt heeft een half uur gecomputerd met de Playstation.*
- *Cliënt frunnikt een half uur lang voortdurend aan haar nagels en shirt.*
- *In de kamer liggen tien kleding stukken en een bord met pasta van gisteravond op de grond. De ruimte is rommelig en niet schoon.*

Voorbeelden niet juist:

- *Op de kamer liggen meer spullen op de grond dan normaal. Het is niet opgeruimd en schoon.*
 - *Dit is te vaag met omschrijvingen als “meer spullen” en “ normaal”*
- *De cliënt zegt dat zij zich verdrietig voelt*
 - *Dit is subjectief en hoort bij stap 1*
- *De cliënt is boos*
 - *Dit is een interpretatie. Schrijf dan liever: Cliënt roept met luide stem en slaat tweemaal op de tafel.*

Stap 3: Omschrijf jouw **analyse**. Welke conclusie trek jij op basis van de subjectieve en objectieve waarnemingen? Wat denk jij dat er aan de hand is?

Voorbeeld: Vanuit de uitspraken van mevrouw en de omgeving die er rommelig uitziet lijkt het erop dat mevrouw onrust en onduidelijkheid ervaart. De omgeving zag er rommelig uit omdat er kleding op de grond lag en etensresten op tafel lagen. In haar signaleringsplan is terug te vinden dat zij haar kameronderhoud laat liggen wanneer zij het overzicht niet meer heeft en zij zich niet goed voelt. Ook staat er in haar signaleringsplan dat het frunniken, snel praten en vluchtig ademen tekenen zijn van stress.

Stap 4: Omschrijf het **plan** dat is uitgevoerd of wat je uit gaat voeren. Wat ga je doen? Wat is de reactie van de cliënt hierop? Hoe moet er verder gehandeld worden? Welke afspraken zijn er gemaakt, wie doet wat en wanneer?

Voorbeeld: Samen met mevrouw een rondje gaan wandelen. Uit het signaleringsplan en uit het verleden is gebleken dat dit helpend kan zijn voor mevrouw. Voornamelijk een route door het bos is helpend. Nadat we een half uur hebben gewandeld werd mevrouw rustiger. Mevrouw oogt rustiger, gezien ze niet meer frunnikt aan haar kleding. Mevrouw geeft aan naar huis te willen. Ik heb aangegeven dat we dat gaan doen en dan samen haar kamer op gaan ruimen, zodat ze nog meer rust kan krijgen. Mevrouw vond dit een goed idee. Bij thuiskomst samen haar kamer opgeruimd en aansluitend een kopje theegedronken met de medebewoners.

Waarborg de privacy van betrokkenen

- Verwijs naar anderen door hun rol te benoemen (bijvoorbeeld partner) of door initialen.

Rapportage frequentie teamlocaties (intramuraal)

Er wordt iedere dag gerapporteerd. Belangrijke ontwikkelingen worden altijd direct vastgelegd. Minimaal eenmaal per week wordt er op ieder doel uit het ondersteuningsplan gerapporteerd.

- *Bij het rapporteren op een doel is het van belang om duidelijk te benoemen hoe er aan het doel is gewerkt.*
- *Wanneer er niet aan een doel gewerkt is, dan kan dit ook gerapporteerd worden. Benoem dan om welke reden er niet aan dit doel gewerkt is deze week.*
- De rapportage bevat de meest recente situatie. Zorgelijke situaties worden binnen 24 uur gerapporteerd en doorgegeven aan de gedragswetenschapper via telefonisch contact.

Rapportage frequentie teamlocaties (Extramuraal)

Elk contactmoment wordt gerapporteerd. Belangrijke ontwikkelingen worden altijd direct vastgelegd. Minimaal eenmaal per week wordt er op ieder doel uit het ondersteuningsplan gerapporteerd.

- *Bij het rapporteren op een doel is het van belang om duidelijk te benoemen hoe er aan het doel is gewerkt.*
- *Wanneer er niet aan een doel gewerkt is, dan kan dit ook gerapporteerd worden. Benoem dan om welke reden er niet aan dit doel gewerkt is deze week.*
- De rapportage bevat de meest recente situatie. Zorgelijke situaties worden binnen 24 uur gerapporteerd en doorgegeven aan de gedragswetenschapper via telefonisch contact.

Rapportage frequentie gezinshuizen (intramuraal)

Er wordt minimaal wekelijks op ieder doel uit het ondersteuningsplan gerapporteerd. Belangrijke ontwikkelingen worden altijd direct vastgelegd.

- *Bij het rapporteren op een doel is het van belang om duidelijk te benoemen hoe er aan het doel is gewerkt.*

- *Wanneer er niet aan een doel gewerkt is, dan kan dit ook gerapporteerd worden. Benoem dan om welke reden er niet aan dit doel gewerkt is deze week.*
- *De rapportage bevat de meest recente situatie. Zorgelijke situaties worden binnen 24 uur gerapporteerd en doorgegeven aan de gedragswetenschapper via telefonisch contact.*

Rapportage frequentie gezinshuizen (Extramuraal)

Gezinshuisouders leveren doorgaans geen extramurale zorg. Indien dit toch voorkomt, geldt het volgende:

Elk contactmoment wordt gerapporteerd. Belangrijke ontwikkelingen worden altijd direct vastgelegd. Minimaal eenmaal per week wordt er op ieder doel uit het ondersteuningsplan.

- *Bij het rapporteren op een doel is het van belang om duidelijk te benoemen hoe er aan het doel is gewerkt.*
- *Wanneer er niet aan een doel gewerkt is, dan kan dit ook gerapporteerd worden. Benoem dan om welke reden er niet aan dit doel gewerkt is deze week.*
- *De rapportage bevat de meest recente situatie. Zorgelijke situaties worden binnen 24 uur gerapporteerd en doorgegeven aan de gedragswetenschapper via telefonisch contact.*

Wanneer een rapportage markeren?

- Een rapportage wordt gemarkeerd als deze een onveilige situatie beschrijft*.

*Indien er sprake is van een onveilige situatie moet ten alle tijden het passende protocol hiervoor gevolgd worden.

Naast de rapportage moet in sommige gevallen een RAI- of een MIC-registratie gedaan worden. RAI wordt ingevuld bij ongewenst gedrag van een cliënt. De MIC-registratie wordt gedaan als er sprake is van een incident door toedoen of nalatigheid van een medewerker of ten gevolge van een organisatorisch of materieel gebrek, waarbij de gedupeerde een cliënt is (zie kwaliteitsdocument 305 en 308).

Tips voor een goede rapportage

- Rapporteer volgens de SOAP-methode.
- Schrijf respectvol over de cliënt en naaste(n). Ben je er bewust van dat cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger ten alle tijden de rapportages op mag vragen.
- Vermeld wat je hebt afgesproken met de cliënt en/of naaste(n).
- Beschrijf alleen feiten en geef niet je eigen mening. Wil je toch je mening geven, geef dan duidelijk aan dat het om jouw mening gaat en omschrijf deze op respectvolle en professionele wijze en geef aan of je deze met de cliënt besproken hebt.
- Heeft een situatie je aangegrepen of ben je nog emotioneel over een situatie, wacht dan even met rapporteren of spreek een collega, zodat je wat later objectief kunt rapporteren.
- Trek geen conclusie en stel geen diagnose als je daartoe niet bevoegd bent.
- Gebruik geen afkortingen die niet gangbaar zijn in de Nederlandse taal en vermijd vaktaal. Schrijf zodat iedereen het kan begrijpen en met volledige zinnen.
- Let op taal-, schrijf- en typefouten. De automatische correctie kan onbedoeld voor vreemde zinnen zorgen. Vraag eventueel of een collega meeleest ter controle.
- Schrijf kort, krachtig en volledig zodat navraag niet nodig is.
- Rapporteer waar het kan op de doelen uit het zorgplan.